EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 91905
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-03 08:14:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: IRENE DEL CARMEN FIGUEROA FAUNDEZ			RUN	: 10.257.526-1
F.Nac	: 25-09-1933	Edad	: 90 AÑOS, 11 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-08-29	Fecha Egreso	: 2024-09-03 08:14:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. K52.8-OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS ESPECIFICADAS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1-Neumonía por broncoaspiración
2-Deshidratacion moderada
3-Insuficiencia cardiaca
4-HTA sistemica
5-Usuaria Macapaso Bicameral

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J15.9-NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente traída por familiares quienes refieren compromiso del estado general de 1 semana aprox de evolución. Destacan inapetencia y ausencia de hidratación oral. Previamente con episodio de nauseas, vómitos y diarrea, autolimitado (con otros familiares afectados por mismo cuadro). Se anexa al cuadro exacerbación de accesos de tos con mayor expectoración basal, por lo que acuden.
Durante estancia hospitalaria paciente en mejores condiciones generales, recibiendo terapia ATB endovenosa acorde: Ceftriaxona 2gr ev (5 días) además de Metronidazol.
Parámetros inflamatorios en descenso, compromiso transitorio ELP (hipokalemia), sin comrpomiso de función renal.
En vista de inapetencia y compromiso, se instaló sonda nasogástrica la cual persiste a la fecha.
Paciente persiste con rechazo oral voluntario. Desde el punto de vista de fonoaudiología, con estructuras conservadas y funcionales como para deglutir.
En vista de condición clínica estable y mejoría general se deriva para continuidad de atención HODOM.

PLAN DE MANEJO:

Hemodinamia/Cardiovascular: buen llenado capilar, cifras tensionales con tendencia a Hipotension. se ajusta BB. , se ajusta antiagregacion.
Ventilatorio: al momento sin FIO2 adicional , adecuada mecanica ventilatoria.
Infeccioso: 02/09 Parámetros inflamatorios en descenso. Recibiendo ceftriaxona + metronidazol en 5to día. Cumplir terapia durante al meno 7 días.
Neurologico: vigil consciente, desorientada.

INDICACIONES AL ALTA

1. Derivo HODOM
2. Regimen Fresubin a 35cc/h VSNG | Seguimiento fonoaudiología: procurar papilla y VO
3. Escitalopram 10mg tomar 1.1/2 cada 24 horas
4. Ceftriaxona 2gr ev día (2 días)
5. Metronidazol 500mg vo/vsng c8h (2 días)
6. AAS 100 mg vo dia
7. Carvedilol 6.25mg vo c12h
8. ATV 40mg vo dia
9. Espironolactona 25mg vo dia
10. Isosorbide 10mg vo dia
11. Seguimiento fonoaudiología
12. Control SU SOS

EXÁMENES Y RESULTADOS

31/08 Albumina: 2,5 * | Creatinina: 0,90 | Calcio: 8,5 | Clearence Calculado (MDRD): 58,82 * | Proteina C Reactiva: 134,0 * | Uremia: 82 * | Nitrógeno Ureico (BUN): 38 * | Sodio: 140,00 | Potasio: 3,50 | Cloro: 109,00 * | Leucocitos: 10,10 | Hematíes: 3,79 * | Hematocrito: 33,8 | Hemoglobina: 11,5 | VCM: 89,2 | HCM: 30,4 | CHCM: 34,0 | RDW: 13,0 | Plaquetas: 114 *

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO